

AFEȚIUNI CUTANATE BACTERIENE

- **Flora rezidentă (germeni aerobi si anaerobi)**

Zone uscate/umede si bogate in sebum

Strat cornos/Foliculul pilosebaceu

- coci gram + (*Staf. epidermidis*)
- bacili gram + (*Corynebacterii*)
- anaerobi (*Propionibacterium*) - foliculi
- levuri (*Pityrosporum*)

- **Floră tranzitorie si temporară**

- enterococ, staf.aureu, streptococi, pseudomonas

Factori favorizanți

- Patogenitatea bacteriei
- Terenul gazdei:
 - filmul hidro-lipidic superficial (mantaua acida a pielii)
 - secretia sebacee + sudoripara
 - pH = 4 – 7
 - aspectul tegumentului – uscaciunea, maceratia, sol continuitate
 - imunitatea generala

IMPETIGO

Infectie bacteriană acută non-foliculară, contagioasă

Etiologie: *Stafilococ aureus*: forma buloasă

- Purtători sanatoși (nazofaringe, zona perianala, axile)
- Transfer prin frecarea sau gratarea tegumentului; contact interuman direct sau cu obiecte personale infectate
- Invazia straturilor superficiale ale pielii
- Leziunile preexistente (dermatita atopica, scabia, leziuni de grataj) favorizeaza infectia
- Copii in colectivitati

- La nivelul fetei, in jurul nasului si gurii, gât si mâini, perianal, fese si membre
- Pot fi prezente simultan cheilita angulara si paronichia
- Limfadenopatie loco-regionala
- Vindecare fara cicatrici
- Laborator: frotiu colorat Gram sau cultura din bula intacta

CLINIC: Macule eritematoase izolate, de mici dimensiuni, pe care se dezvoltă rapid vezicule sau bule cu lichid serocitrin initial care se sparg și lasă eroziuni acoperite de **cruste galbene** (melicerice)-element caracteristic!!!

Leziunile devin coalescente (lichidul devine purulent), se extind local sau la distanță prin auto-inoculare



Tratament impetigo

- **Impetigo localizat:**

- dezinfecție cu soluții **antiseptice** (clorhexidina 1% sau povidone iodat-comprese/badijonare) 7-10 zile
- antibiotic local: crema sau unguent cu **acid fusidic** (Fucidin), bacitracina&neomicina (Baneocin), mupirocina (Bactroban), retapamulina (Altargo/Altabax) 10-14 zile

- **Impetigo extins:**

- se asociază trat. atb oral cu Cefalexin/
Cefaclor/Augmentin/Unasyn/macrolide 7-10 zile
- Măsuri de evitare a răspândirii infecției (personal și colectivitate), supraveghere pacienți scabie și suprainfecție *S. pyogenes* (tulpini nefritogene)

Erizipelul

- **Infectie cutanata acuta indusa de Streptococcus pyogenes (beta-hemolitic de grup A)**
- Tropism pentru vasele limfatice (explica recurenta bolii)
- 30% din pacienti sunt purtatori de S. pyogenes in cavitatea nazală
- Factori favorizanti: defecte de bariera cutanata (infectie herpetica, fisuri perinazale, tinea pedis, ulceratii gambe, trauma cutanata minora), alcoolism, obezitate, insuficienta cardiaca, interventiile chirurgicale
- Localizare frecventa: membre inferioare, față, după mastectomie sau disectie ggl limfatici (sdr. de braț gros)
- Laborator-bioumoral: VSH accelerat, leucocitoza cu neutrofilie, PCR si fibrinogen crescute. S.pyogenes se cultiva cu dificultate din aspiratul steril
- Dg. dif: dermatita de contact acuta, zona zoster, sdr. compartimental, hipodermita, angioedem ereditar



Clinic: debut brutal cu febra si frisoane, aparitia unui placard eritematos-edematos rapid progresiv si dureros, bine delimitat (“burelet”) suprafata lucioasa sau cu aspect de “coaja de portocala”, limfadenopatie loco-regionala

Forme complicate de erizipel:

Erizipel bulos



Imunodepresie, DZ, tulburari circulatorii la nivelul membrului afectat, initiere tardivă a tratamentului adecvat

Tratament erizipel

- **General:** antibioterapie **sistemică** promptă
- **Penicilina G** (8 mil ui/zi iv.) doza poate fi mai mare în funcție de greutatea pacientului 10-14 zile
- În cazul răspunsului clinic nefavorabil sub penicilina G se adm. aminopeniciline sau cefalosporine sau clindamicina cu aminoglicozide
- La pacienți alergici la beta-lactamine se adm. macrolide sau cefalosporine de gen 2 sau 3, durata tratamentului crește la 3 săptămâni
- Profilaxia recurențelor (scheme orale cu Penicilina G sau intramusculare cu Moldamin 1-2 ani) pentru a preveni apariția limfedemului secundar
- Tratamentul **local:** repaus la pat, poziție proclivă, comprese umede, evitarea mobilizării zonei afectate
- Identificarea și tratamentul **portii de intrare** a *S. pyogenes*

Limfedem sekundar post-erizipel recurent



(c) University Erlangen,
Department of Dermatology
Phone: (+49) 9131-85-2727

Celulita

- Infectie cutanata profunda indusa de *S. pyogenes*, *S. aureus*, b. gram-negative, anaerobi
- Favorizata de traume cutanate minore, plagi chirurgicale, ulceratii, intepaturi, muscaturi, diseminare in tegument la pacienti septici
- La pacienti cu imunodepresie se poate complica cu afectare fasciala si musculara (fasciita necrotizanta)
- Dg. Dif: erizipelul, tromboza venoasa profunda
- Tratament: atb parenteral cu spectru larg (Augmentin, cefalosporine gen 3) 14 zile, drenaj chirurgical (aparitie de colectii/abcese) sau debridarea necrozelor, comprese locale cu antiseptice

- Clinic: placard eritemato-edematos, dureros, care se extinde treptat, flu delimitat, cu aspect de coaja de portocala, In evolutie pot sa apara necroze profunde, formare de abcese si ulceratii secundare
- **Celulita periorbitala**
(la copii, H. influenzae)



Angina Ludwig

- celulita spatiului submandibular, submaxilar, sublingual, bilateral, durere la masticatie si miscare, tegumentul devine dur, lemnos
- Sursa infectiei: dentara (50%)



Foliculite stafilococice

- Infecția foliculului pilosebaceu cu *S. aureus*
- Zone cu fire de păr terminal sau velus
- Favorizată de: hipersudorație, macerarea tegumentului, fricțiune, medicație topică (dermocorticoizi, compuși halogenati) sau ocluzivă (uleiuri), DZ, HIV/SIDA
- Dg. Dif: foliculite induse de fungi, paraziti, alte bacterii, inflamatorii (non-infecțioase)
- **Foliculite superficiale**
- **Foliculite profunde**

Foliculite superficiale

- Climat umed, vara,
- copii (pe scalp) si sexul masculin (gât, față, axile)
- Pustula centrata de firul de par, eritem perilezional, fara simptome asociate
- vindecare spontana fara cicatrici
- Tratament: solutii antiseptice si atb topice; atentie la igiena personala



Foliculite profunde

Foliculita bărbii (sycozis barbae)

- Pustule centrate de firul de par, multiple, insotite de durere sau prurit, cruste, vindecare fara cicatrici
- pot deveni cronice, leziuni granulomatoase, cicatrici
- igiena locala!!! Barbierit!!!
- Tratament local: identic forma superficiala

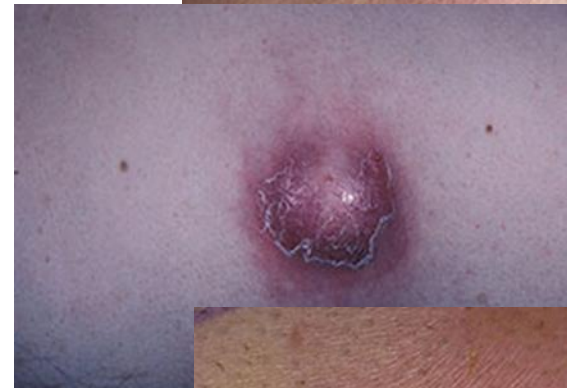


Furunculul

- Infecția stafilococică cuprinde și **spațiul perifolicular producând o importantă colecție purulentă** și necroza foliculului pilosebaceu
- Leziune unică (cel mai frecvent), adulți tineri, sex masculin, zone bogate în foliculi pilosebacei supuși la fricțiune (brate, coapse, fese, perianal, zona genitală), purtători de *S. aureus*, contact interuman direct sau cu obiecte contaminate
- Adulți sănătoși sau în condiții de imunodepresie (DZ, HIV/SIDA)
- Rar apar febră, frisoanele sau limfadenopatia (semn de gravitate)
- Dg. Dif: acneea inversă, infecții micotice (kerion celsi)

Clinic:

- Aparitia unui nodul inflamator cu toate semnele celsiene prezente, cu o mica pustula galbuie la suprafata,
- In citeva zile nodulul devine fluctuent, centrul leziunii se necrozeaza, formând burbionul
- Burbionul se elimina spontan in urmatoarele zile, lasând o ulceratie (durerea locala si inflamatia dispar) care se vindeca cu o cicatrice inestetica



Furunculul malign al fetei/stafilococia maligna a fetei

- Prezenta unui furuncul la nivelul buzei superioare sau a fetei (frunte)
- Edem inflamator important al zonei afectate cu palparea unui nodul fluctuent in grosimea edemului si o eventuala mica pustula la suprafata tegumentului
- Complicatie redutabila: traumatizarea leziunii produce **tromboza septica de sinus cavernos**, infectia disemineaza prin sinusurile venoase la baza creierului, deces 90%, cefalee extrema, febra mare, chemozis conjunctival, diplopie, coma



Tratament furuncul

- Sistemic: atb antistafilococice sau cefalosporine gen 1 si 2 administrate oral sau iv. (stafilococia maligna a fetei) 7 zile
- Local: badijonare/comprese cu solutii antiseptice (clorhexidina, octenisept, povidone-iodine), aplicare de creme/unguente cu atb topice, in stadiul initial se poate aplica **ichtiol** 10% cu scop reductor
- Chirurgical: incizia si drenajul continutului necrotic doar sub tratament sistemic cu atb, previne aparitia cicatricii inestetice
- **NU** se intervine mecanic pe stafilococia maligna a fetei

Furunculoza

- Prezenta de furuncule **multiple** concomitent sau recurente
- Imunodepresie
- Purtatori de *S. aureus* nazal
- Igiena riguroasă, săpun antibacterian
- Tratament oral cu Clindamicina 600 mg/zi 14 zile
- Local: nazal Mupirocina



Carbunculul

- Aparitia in acelasi timp de furuncule multiple grupate intr-un placard inflamator pseudo-tumoral, semne celsiene prezente,
- Febra si adenopatie loco-regionala
- Sex masculin, adulti, regiunea cefei,
- Eliminarea burbionului concomitenta din leziunile multiple: aspect de stropitoare
- Vindecare cu cicatrici cheloidiene
- Tratament sistemic cu atb antistafilococice asociat cu drenaj chirurgical



Cheilita angulară

(*Angulus streptococic*)

- Prezenta de fisuri dureroase pe un fond eritematos la nivelul comisurilor bucale, unilateral sau bilateral
- Tratament local: antiseptice, topice atb

